

1) Introducción y relevancia clínica

La **otitis media aguda (OMA)** es una de las infecciones más frecuentes en la infancia y principal causa de indicación antibiótica en pediatría. Un subgrupo de niños presenta **episodios repetidos** que configuran la **otitis media recurrente (OMR)**, entidad que impacta en la **calidad de vida**, la **asistencia escolar**, el **uso de antibióticos** y el **desarrollo del lenguaje** por hipoacusia conductiva asociada.

Definición estandarizada (que debes memorizar):

- **≥3 OMA en 6 meses o ≥4 en 12 meses** (con ≥1 episodio en los últimos 6 meses).

Esta definición es la usada en guías internacionales y en la práctica nacional.

Importancia en Chile:

- Alta carga en **jardines infantiles** y hogares con **hacinamiento** o **exposición a humo de tabaco**.
- Interfase frecuente con **APS**, donde se decide observación, antibióticos, vacunación y derivación a ORL para **tubos de ventilación** y, en casos seleccionados, **adenoidectomía**.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Microbiología habitual

Los agentes clásicos de OMA (y, por ende, de OMR) son:

- **Streptococcus pneumoniae**
- **Haemophilus influenzae no tipificable**
- **Moraxella catarrhalis**

Tras la introducción de **vacuna antineumocócica conjugada (PCV)**, disminuyeron serotipos invasores de *S. pneumoniae*, pero la OMR persiste por **colonización nasofaríngea** y **disfunción de trompa de Eustaquio**.

2.2 Disfunción de trompa de Eustaquio (TE)

La TE es **más corta y horizontal en lactantes**, facilitando el ascenso de secreciones desde nasofaringe al oído medio. La **inflamación viral** (resfrío), alergia y **hipertrofia adenoidea** empeoran la ventilación del oído medio, generando **presión negativa y efusión**; esto reduce defensas locales y facilita sobreinfección bacteriana.

2.3 Factores de riesgo

- **Edad <2 años, asistencia a sala cuna/jardín, hermanos en edad escolar.**
- **No lactancia materna** o lactancia breve (<6 meses).
- **Exposición a humo de tabaco** (intra/extra domiciliario).
- **Uso de chupete** más allá de los 6–12 meses.
- **Hacinamiento, bajo nivel socioeconómico.**
- **Alergia rinitis, reflujo gastroesofágico, fisura palatina** o disfunciones craneofaciales.
- **Inmunodeficiencias** (p. ej., déficit de IgA, anticuerpos específicos) en una minoría.

2.4 Concepto de portador nasofaríngeo

Niños que **colonizan** con *H. influenzae* o *M. catarrhalis* presentan **recurrencias** tras infecciones virales que descompensan la trompa; la microbiota nasofaríngea y el intercambio en sala cuna son claves.

3) Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Presentación clínica

Los cuadros de OMR son “repeticiones” de OMA típicas:

- **Inicio súbito** con **otalgia, fiebre variable, irritabilidad, disminución del apetito, insomnio.**
- En lactantes: **tira de la oreja**, llanto inconsolable.

Entre episodios, los niños pueden estar **asintomáticos** o mantener **efusión** (otitis media con efusión, OME), con **hipoacusia conductiva** fluctuante y **sensación de oído tapado** (niños mayores).

3.2 Otoscopia en OMA

- **Tímpano abombado/eritematoso, opaco**, con **movilidad disminuida** (otoscopia neumática).
- Nivel hidroaéreo o **otorragia** si hay perforación.

3.3 Diagnóstico diferencial

- **OMA aislada** (no cumple criterios de recurrencia).
 - **Otitis media con efusión (OME)**: líquido en oído medio **sin signos de infección aguda** (sin dolor/fiebre).
 - **Otitis externa**: **otalgia intensa** con **dolor a la tracción** del pabellón y **CAE eritematoso**; tímpano sano.
 - **Dolor referido** por faringitis/erupción dentaria (tímpano normal).
 - **Colesteatoma** (inusual en OMR; sospechar si **otorrea fétida crónica** o **masa perlada**).
-

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

La OMR se establece por **historia documentada** de episodios de OMA que cumplan criterios clínicos (otalgia + otoscopia compatible, con o sin fiebre). **Registrar fechas y lado comprometido** ayuda a decidir derivación.

4.2 Herramientas de apoyo

- **Timpanometría**:
 - **Tipo B** en OME (curva plana) → sugiere **efusión**.
 - **Tipo C** (presión negativa) → **disfunción tubárica**.

- **Audiometría** (desde 4–5 años, o potenciales evocados/otoemisiones en menores): pesquisa de **hipoacusia conductiva** sostenida.
- **Nasofibroscopía** (ORL): útil si se sospecha **hipertrofia adenoidea** relevante u otra obstrucción nasofaríngea.

4.3 Red flags que obligan a ampliar estudio

- **Mala ganancia ponderal, infecciones severas recurrentes** (neumonías, sepsis), **diarreas crónicas** → descartar **inmunodeficiencia**.
- **OMA unilateral persistente** con efusión en **adolescentes**: extremadamente raro, pero recordar patología nasofaríngea si hay epistaxis/obstrucción nasal.

5) Tratamiento (según guías MINSAL / práctica estándar en Chile)

El manejo integra **tres ejes**: (1) tratar **cada episodio** de OMA; (2) **prevenir recurrencias** corrigiendo factores de riesgo; (3) decidir **intervenciones ORL** (tubos/adenoidectomía) en casos seleccionados.

5.1 Manejo del episodio agudo de OMA dentro de OMR

A. Analgesia y observación

- Paracetamol 10–15 mg/kg/dosis c/6–8 h; Ibuprofeno 10 mg/kg c/6–8 h.
- **Observación 24–48 h** es razonable en >6 meses **sin criterios de gravedad** (otalgia leve, T° <39 °C, buen estado general).

B. Antibióticos (indicación si <6 meses, OMA severa, bilateral <2 años, otorrea, o fracaso de observación):

- **Amoxicilina 80–90 mg/kg/día** dividida cada 12 h (primera línea).
- Si **amoxicilina reciente** (últimos 30 días), **conjuntivitis purulenta** o **fracaso terapéutico a las 48–72 h** → **Amoxicilina/ácido clavulánico 90/6,4 mg/kg/día** c/12 h.
- **Alergia inmediata a penicilina**: **Azitromicina** (10 mg/kg día 1, luego 5 mg/kg/día días 2–5) o **Claritromicina**; considerar **Cefdinir/Cefuroxima** en alergias no

anafilácticas (cruzadas).

- **Duración:**
 - **10 días** si <2 años o cuadro severo,
 - **7 días** si 2–5 años leve-moderado,
 - **5–7 días** si ≥6 años leve-moderado.

C. Fracaso terapéutico

- Reevaluar otoscópicamente, confirmar adherencia y dosis.
- Cambiar a **Amoxi/Clavulánico** alta dosis si inició amoxi; o **Ceftriaxona 50 mg/kg EV/IM al día** por 1–3 días en imposibilidad VO/vómitos.

Perforación timpánica con otorrea: agregar **gotas óticas con quinolona** (ciprofloxacino) + manejo sistémico según evolución.

5.2 Prevención de recurrencias (pilar en OMR)

Intervenciones con mejor evidencia:

- **Lactancia materna** (al menos 6 meses).
- **Evitar humo de tabaco** (intragdomiliario y terceros).
- **Vacuna antineumocócica conjugada (PCV)** según PNI.
- **Vacuna influenza** anual (reduce OMA posviral).
- **Higiene nasal** con suero fisiológico en rinitis virales.
- **Suspender chupete** a partir de los 6–12 meses.
- **Disminuir asistencia a sala cuna** si es posible en lactantes con OMR severa.

Intervenciones con evidencia limitada o no recomendadas de rutina:

- **Antibioticoprofilaxis** continua (p. ej., amoxicilina nocturna): **NO** recomendada de forma general por resistencia y efectos adversos; puede considerarse **excepcionalmente** en OMR estacional muy marcada mientras se coordina intervención ORL.

- **Xilitol** (chicles/soluciones): evidencia mixta; no forma parte de recomendaciones estándar en Chile.
- **Tratamientos antirreflujo** solo si hay clínica clara de RGE.

5.3 Derivación a Otorrinolaringología (criterios prácticos)

Derivar si:

- Cumple **definición de OMR** ($\geq 3/6$ meses o $\geq 4/12$ meses).
- **OMA severas** (complicadas) o **persistencia de OME** >3 meses con **hipoacusia** demostrada.
- **Fracaso** de medidas preventivas y antibióticos apropiados.
- Sospecha de **hipertrofia adenoidea** significativa (ronquido habitual, respiración bucal, rinitis crónica) o **malformaciones craneofaciales**.

5.4 Intervenciones ORL

A. Tubos de ventilación transtimpánicos (diábolo)

- Indicados en **OMR con efusión** al momento de evaluación o **OME persistente** con **hipoacusia** o **retraso del lenguaje**.
- Beneficios: ↓ episodios de OMA, ↓ dolor, **mejora de audición inmediata**.
- Riesgos: otorrea transitoria, **timpanoclerosis**, perforación residual (baja frecuencia).
- Cuidados: **evitar inmersión profunda** sin protección; control periódico.

B. Adenoidectomía

- Considerarla en **≥ 4 años** con OMR y **hipertrofia adenoidea** o **OME persistente**, especialmente si ya se colocaron tubos y recurre.
- Beneficio: mejora ventilación nasofaríngea y reduce secreciones.

C. Timpanoplastía

- No es tratamiento de OMR; reservada para **perforaciones persistentes** post-tubos o secuelas.

6) Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones de OMR/OME

- **Hipoacusia conductiva** fluctuante (15–30 dB).
- **Retraso del lenguaje y déficit atencional** en preescolares.
- **Perforación timpánica y timpanoclerosis**.
- **Colesteatoma adquirido** (raro; asociado a **retracción timpánica** y OME crónica).
- **Mastoiditis aguda** (poco común pero grave).
- Complicaciones intracraneanas (**meningitis, absceso cerebral**): muy raras hoy.

6.2 Pronóstico

- La mayoría **mejora con la edad** por maduración de la trompa y menor exposición a virus.
- **Tubos de ventilación** mejoran audición y reducen episodios durante su permanencia (6–12 meses).
- Pronóstico lingüístico favorable si se corrige hipoacusia y se realiza **estimulación del lenguaje**.

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas (para acertar preguntas)

1. **Definición de OMR: $\geq 3/6$ meses o $\geq 4/12$ meses** (con ≥ 1 en los últimos 6).
2. Si hay **efusión** al evaluar OMR, **tubos transtimpánicos** son la intervención con mayor beneficio.
3. **Antibioticoprofilaxis** NO es de uso rutinario; considerar **vacunas (PCV, influenza)**, **lactancia** y **control de humo**.

4. En **<2 años** con OMA bilateral o severa → **amoxicilina alta dosis** es de elección.
5. **Timpanometría tipo B** = OME; **tipo C** = disfunción tubárica.
6. **Adenoidectomía** ayuda en **≥4 años** con OMR/OME persistente y clínica nasofaríngea.
7. Pensar en **inmunodeficiencia** si hay infecciones severas, crecimiento comprometido o mala respuesta a terapias.

Errores comunes (que te quitan puntos)

- Diagnosticar OMR sin **criterio temporal claro** (sumar cuadros no documentados).
 - Indicar **antibióticos** en **OME** (no hay infección aguda).
 - Prescribir **profilaxis antibiótica** prolongada sin respaldo.
 - No ofrecer **vacuna influenza** o **consejería de humo** en OMR.
 - No **derivar a ORL** pese a OMR con efusión e hipoacusia.
 - No pesquisar **retraso del lenguaje** ni solicitar **audiometría** en OME crónica.
-

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Otitis media recurrente: ≥3 OMA/6 meses o ≥4/12 meses**; es frecuente en preescolares y se asocia a **disfunción de trompa de Eustaquio** y exposición viral.
2. El manejo del **episodio agudo** prioriza **analgesia** y, si corresponde, **amoxicilina alta dosis**; ajustar a **amoxi/clavulánico** ante riesgo de *H. influenzae* productor de β-lactamasa.
3. La **prevención** se basa en **PCV + influenza, lactancia materna**, evitar **humo de tabaco**, higiene nasal y limitar **chupete**.
4. **Timpanometría** y **audiometría** guían la conducta; **OME persistente** con hipoacusia exige intervención.
5. **Tubo transtimpánico** es la estrategia más efectiva en OMR con efusión; **adenoidectomía** se suma en mayores de 4 años con obstrucción/OME refractaria.

6. La **antibioticoprofilaxis** no se recomienda de rutina (resistencia/efectos adversos).
7. Vigilar **desarrollo del lenguaje** y derivar a fonoaudiología cuando sea necesario; el pronóstico mejora con maduración y manejo oportuno.